

Maladie de Behçet

I. Introduction :

• Maladie de Behçet :

- Vascularite de l'adulte jeune, homme
- Maladie systémique
- Atteinte principale cutanéomuqueuse, oculaire et articulaire
- Poussées – rémission : maladie chronique
- Cause inconnue
- Morbidité / mortalité

• Premières descriptions :

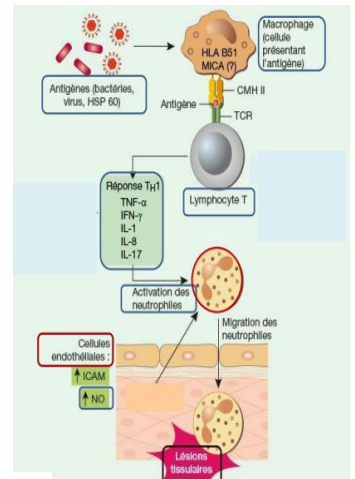
- Hippocrate
- L'ophtalmologue : Beneditktos Adamantiades (1930)
- Le dermatologue turc : Hulusi Behçet (1937)

II. Épidémiologie :

- Adulte jeune (20- 50 ans)
- Prédominance masculine
- Maladie de la route de soie (méditerranéen au japon)
- En Algérie : ?
- Au service de médecine interne CHU Tizi-Ouzou : Total : 181 patients, 115 hommes, 66 femmes

III. Physiopathologie :

- Mystérieuse
- Vascularite d'étiologie et de pathogénie inconnues : neutrophilique ou lymphocytaire
- Facteurs déclenchants : Infection, environnement
- Histologie : Vascularite, thrombose
- Mécanismes : Génétique (HLA B51), immunologique
- La physiopathologie de la MB est caractérisée par :
 - Vascularite : lésions vasculaires et périvasculaires.
 - Hyperactivité neutrophilique avec afflux de neutrophiles dans les tissus : lésions tissulaires



IV. Diagnostic :

- Le diagnostic est clinique
- Aucun test biologique
- Critères de classification

1. Les aphtes buccaux :

- Ulcérations douloureuses
- Fréquence : 98%
- Récidivante
- Isolés ou multiples
- Les bords nets
- Tapissés d'un enduit « beurre frais »
- Le pourtour est inflammatoire et douloureux
- Face interne des joues, le sillon gingivolabial, le pourtour de la langue et le frein
- Favorisés par l'alimentation (peau des fruits, noix, noisettes, amandes), les traumatismes dentaires, parfois par les cycles menstruels et les émotions et gêner l'alimentation et l'élocution

➤ Diagnostiques différentiels :

- Aphtose buccale banale
- Aphtoses buccales d'autres causes :
 - Maladie de Crohn,



LA BIOLOGIE

~~NFS
VS
HÉMOSTASE
HLA B5
ANTICARDIOLIPINE
ANCA
ASCA~~

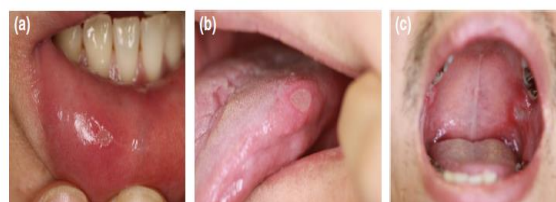


Figure 1. Recurrent oral aphthous ulcers in the (a) lower lip, (b) tongue margin and (c) buccal mucosa.



FIGURE 4
Herpès buccal (coll. M. Samimi)



FIGURE 6
Ulérations buccales médicamenteuses (méthotrexate)
(coll. M. Samimi)

- Rectocolite hémorragique,
- Polychondrite atrophiante,
- Maladie cœliaque
- Carences en fer, en folates, en vitamine B12,
- Hémopathies, déficit immunitaire acquis,
- Prise de nicorandil, captopril,...

➤ Et donc ce qui doit inquiéter :

- Leur **nombre**,
- La **variabilité de leur taille**,
- Leur **diffusion** au palais, au dos de la langue, à l'oropharynx,
- Leur **répétition**,
- L'invalidité qu'ils entraînent
- **Favorisés par l'arrêt du tabac** (au point que les patch de nicotine ont pu être proposés comme traitement)
- Existence d'**autres manifestations CM et Viscérales**

2. Les aphtes génitaux :

- 60 à 65 % des cas
- Très évocateurs de la MB
- Sièges :

Chez l'homme : sur le scrotum, plus rarement sur le fourreau ou au méat urétral

Chez la femme : sur la vulve ou le vagin où ils peuvent être soit disséminés et douloureux, soit totalement latents.

- Les aphtes génitaux laissent, dans deux tiers des cas, des cicatrices dépigmentées permettant un diagnostic rétrospectif.



Cicatrice et aphte génital.

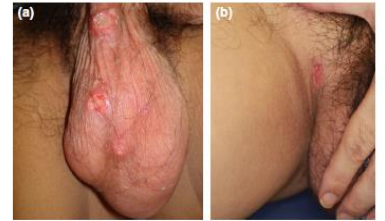
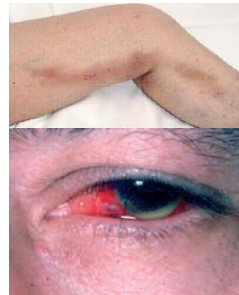


Figure 2. (a,b) Genital ulcers of the scrotum.

3. Autres lésions cutanées :

- L'hyperréactivité cutanée aspécifique aux agressions de l'épithélium
- Pseudo folliculite
- Érythèmes noueux
- Phlébites superficielles
- Papules, vésicules, pustules, purpura, ulcérations cutanées, véritables aphtes cutanés
- Pyoderma gangrenosum



Aphtes cutanés.



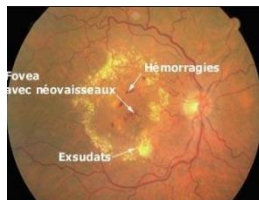
Figure 5. Positive pathergy test. A pustule accompanied by a red halo is noted at the injection site in the left forearm.

4. Atteinte ophtalmologique :

- Troisième rang par leur fréquence
- Bilatérale / toute l'uvée surtout postérieure
- Chez l'homme : plus précoces (révélatrice) et plus graves
- Rare après 50 ans
- Poussées récidivantes d'inflammation endo-oculaire → destruction → Pc vital
- Vision trouble, myosis, douleur périorbitaire, larmoiement (Epiphora), photophobie → Récidive → Complications :
 - Synéchies antérieures ou iridocristalliniennes et à une atrophie irienne
 - Glaucome lié à la fermeture de l'angle iridocornéen secondaire à la seclusion pupillaire ou à la prescription des corticoïdes.



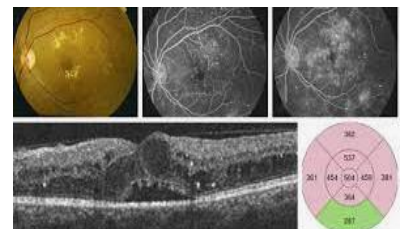
Hyalite cellulaire



Exsudats et hémorragies rétinienes



Papillite



Cédème maculaire

Tableau 2 Aspects cliniques de l'atteinte oculaire au niveau segment antérieur.

Atteinte oculaire	N de cas		N de yeux	
	N = 93 (%)		N = 150 (%)	
Uvéite antérieure	7	7,5	13	8,6
Rubéose irienne	5	5,3	6	4
Epislérite	2	2,1	4	2,6
Sclérite	2	2,1	3	2
Atrophie de l'iris	2	2,1	2	1,3
Ulcère conjonctival	1	1	2	1,3
Kératite	1	1	1	0,6

Tableau 3 Aspects cliniques de l'atteinte oculaire au niveau du segment postérieur.

Atteinte oculaire	Nb de cas		Nb de yeux	
	Nb = 93(%)		Nb = 150(%)	
Vascularite rétinienne	48	51,6	78	52
Atteintes maculaire	25	26,8	33	22
Uvéite postérieure	13	13,9	21	14
Uvéite intermédiaire	10	10,7	16	10,6
Cédème papillaire	10	10,7	15	10
Hémorragie intra vitréenne	2	2,1	3	2
Décollement de rétine	2	2,1	2	1,3

➤ Le pronostic :

- Spontanément : sévère
- Sous TRT : Les lésions évoluent par poussées et régressent le plus souvent incomplètement
- Amélioré par un diagnostic plus précoce, une prise en charge par des équipes spécialisées utilisant au mieux les progrès thérapeutiques
- Complications : Pronostic fonctionnel : risque de cécité

5. Atteinte vasculaire : angio- ou vasculo-Behtcet

- Un homme jeune, sans facteur de risque vasculaire : atteinte inflammatoire
- Atteinte de tous les calibres (veines +++ou artères) (30 %) :
Thromboses veineuses profondes : tous les troncs veineux (localisation banale ou inhabituel +++)
Thrombose de la veine cave inférieure et/ou supérieure ;
Thrombose des veines sus-hépatiques ou syndrome de Budd-Chiari
Thrombose veineuse cérébrale
- Caractère récidivant , bilatéral
- L'atteinte vasculaire est parfois associée à un syndrome fébrile et biologique inflammatoire
- L'atteinte cardiaque : thrombose intra cavitaire
- Cause de mortalité

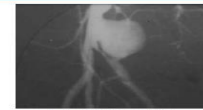


Figure 9. Angiogramme artériel.



Figure 5. Syndrome cave supérieur.



Figure 10. Anévrismes pulmonaires.

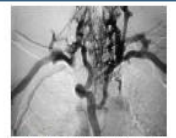


Figure 6. Angiogramme cave supérieur.

6. Atteinte articulaire :

- Dans la moitié (54 %) des cas.
- L'atteinte articulaire est précoce, inaugurale dans 15 à 18 % des cas et peut précéder de plusieurs années les autres manifestations.
- Il s'agit d'arthralgies et/ou d'oligoarthrites inflammatoires fixes, siégeant aux articulations porteuses (genoux, chevilles).
- Les destructions articulaires sont exceptionnelles

7. Atteinte digestive :

- Les manifestations gastro-intestinales ressemblent aux lésions de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, posant des problèmes nosologiques parfois insolubles, au point que l'association des deux maladies a été rapportée
- La fréquence en est diversement appréciée, allant de 5 à 30 %
- Tout le tractus digestif peut être atteint avec une prédominance pour la région iléocœcale
- L'atteinte intestinale peut comporter deux types de lésions : une inflammation de la muqueuse ou une ischémie éventuellement compliquée de nécrose.
- En faveur de la MB :
Atteinte des troncs artériels
Vascularite neutrophilique ou lymphocytaire
- Le risque perforatif est important, de 25 à 50 %, d'autant plus important que les lésions sont nombreuses

8. Atteinte neurologique :

- Les manifestations neurologiques surviennent chez environ 25-30 % des patients
- Les atteintes parenchymateuses(encéphalite / méningoencéphalite) sont plus fréquentes (70-80 % des patients avec atteinte neurologique) que les atteintes extra-parenchymateuses.
 - Les céphalées (> 50 % des cas), associées à un syndrome pyramidal uni- ou bilatéral (50–90 %)
 - Une ataxie cérébelleuse et des troubles sphinctériens (25–40 %)
 - Un ralentissement psychomoteur et des troubles du comportement.
 - Des manifestations épileptiques surviennent dans 5 à 10 % des cas
 - Une méningite lymphocytaire ou puriforme aseptique isolée peut survenir.
 - Des atteintes des paires crâniennes, des troubles sensitifs, des mouvements anormaux ou un syndrome extra-pyramidal peuvent également être observés.

❖ Critères de classification :

Année de publication	International Study Group	International criteria for Behçet's disease	Lésions cutanées	prévalence	description
	1990	2013			
Éléments de classification			Aphthose buccale	97-100%	unipolaire
Aphthose buccale (AB)	Obligatoire	2 points	Aphthose génitale	50-85%	unipolaire
Aphthose génitale (AG)	Facultatif	2 points	Erythème noueux	50%	Hypodermite septale/lobulaire
Atteinte oculaire	Facultatif	2 points	Eruption papulo-pustuleuse	30-96%	Fesses, dos et thorax antérieur Folliculaire ou non
Atteinte cutanée	Facultatif	1 point	Thrombophlébite superficielle	10%	Membres inférieurs
Test pathergique positif	Facultatif	1 point	Dermatoses neutrophiliques	<4%	Sweet, Pyoderma gangrenosum
Arthrite/arthralgie			Lésions induites: Test Pathergique	Variables <5-69%	Aiguille de 20 gauges Lecture à 48H
Atteinte vasculaire		1 point			
Thrombophlébite					
Atteinte cardiovasculaire					
Atteinte neurologique		1 point			
Atteinte digestive					
Orchi-épididymite					
Critères BD si	AB et au moins 2 items facultatifs	Au moins 4 points			

Behçet's syndrome: Facts and controversies

Cem Mat, MD^a, Sebahattin Yurdakul, MD^b, Aysegül Sevim, MD^a, Yılmaz Özyazgan, MD^c, Yalçın Tüzün, MD^{a,*} *Clinics in Dermatology* (2013) 30, 352–361

Critères diagnostiques. International criteria for Behçet's disease (2014) [21]

Aphtes buccaux récidivants 2 points	Aphthose observée par un médecin ou rapportée par le malade de façon crédible avec une fréquence d'au moins trois épisodes en 12 mois
Ulcération génitales récurrentes 2 points	Aphthe ou cicatrice observée par le médecin ou le patient
Lésions oculaires 2 points	Uvéite antérieure, uvéite postérieure ou cellules dans le vitré à l'examen par la lampe à fente Vascularite rétinienne observée par un ophtalmologue
Lésions cutanées 1 point	Erythème noueux Pseudo folliculite ou lésions papulo-pustuleuses ou nodules acnéiformes chez un patient sorti de l'adolescence et qui ne prend pas de corticoïdes
Test d'hypersensibilité 1 point	Test d'hypersensibilité au point de piqûre positif papule érythémateuse de diamètre > 2 mm, 48 heures après sa réalisation
Lésions vasculaires 1 point	Thromboses veineuses Thromboses artérielles ou anévrismes
Atteinte du système nerveux central 1 point	Lésion du parenchyme cérébral Thrombose cérébrale

Le diagnostic est retenu quand le patient a un score ≥ 4 points après exclusion des autres pathologies.

V. Biologie et diagnostic positif :

- Absence de test biologique,
- Le diagnostic est clinique.
- Les critères de classification : diagnostic quasi certain ;
- En leur absence, le diagnostic est probable, dépendant de l'élimination des autres hypothèses et de l'expérience du clinicien.
- Le groupage dans le système HLA n'a aucun intérêt pratique.
- La biopsie cutanée d'une intradermoréaction au sérum physiologique peut mettre en évidence une vascularite avec dépôts de complément.

VI. Pronostic :

- Fonctionnel : atteinte ophtalmologique et neurologique
- Mortalité (5à 9.8%) : atteinte neurologique et cardiovasculaire

VII. Diagnostics différentiels :

- Maladie de Crohn
- PFAPA (Periodic fever adenitis pharyngitis aphthous ulce)
- MAGIC syndrom
- Maladies inflammatoires neurologiques (SEP, sarcoïdose)
- Spondylarthropathies

VIII. Traitement :

Quels sont les objectifs thérapeutiques dans la maladie de Behçet?

- Score d'activité global: BD current activity form (0-12), BD activity score (0-100).....
- Score d'activité spécifique d'organe:
 - Régression des lésions cutanées
 - Indice Articulaire, Indice Synovial
 - Régression inflammation oculaire, hyalite, vascularite rétinienne, œdème maculaire
 - Absence de récurrence de TVP, TVS et/ou d'anévrisme,
 - Régression des lésions SB à IRM cérébrale et Rankin ≤ 1

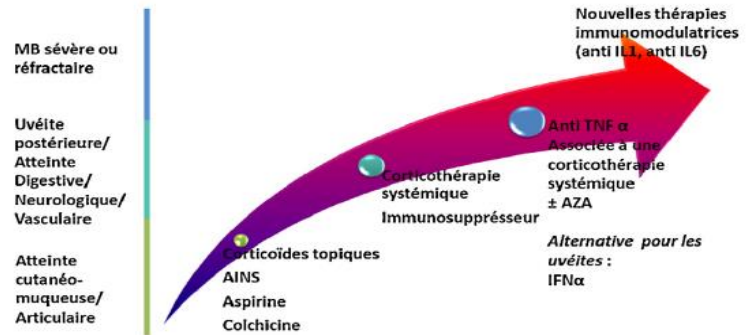
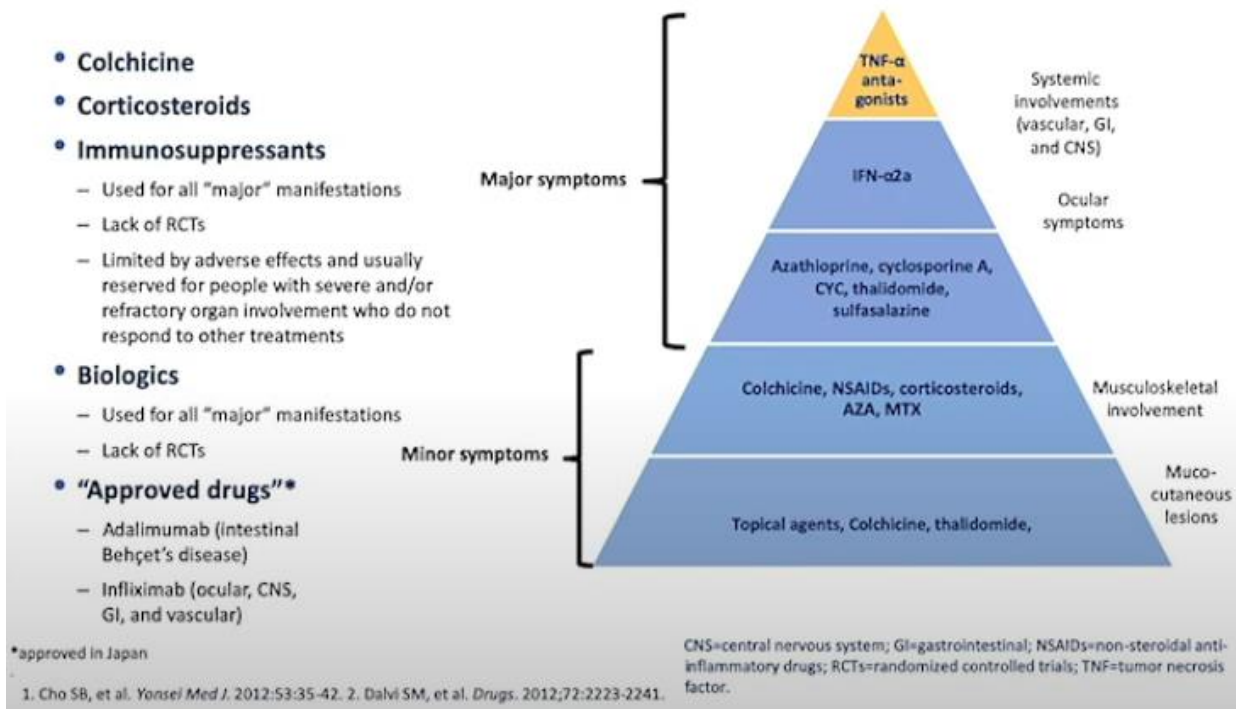


Fig. 1. Stratégie thérapeutique graduée dans la maladie de Behçet. AZA: azathioprine; IFN α : interféron-alpha; anti-IL-1: inhibiteur de l'interleukine 1; anti-IL-6: inhibiteur de l'interleukine 6; AINS: anti-inflammatoires non stéroïdiens; TNF α : tumor necrosis factor alpha.

Clinical algorithm in behçet's disease



IX. Conclusion :

- Maladie inflammatoire vasculaire systémique
- Prédominance des atteintes cutanéomuqueuse, ophtalmologique et vasculaire
- Formes masculines plus graves
- Traitement (colchicine , CRC, IS et biothérapies)